



DREAM AND DO IT
TRAINING UND COACHING FÜR IHREN ERFOLG

COACHING-CONTENT

SITZEN & SEITENSCHLAFEN

Risiken für Muskeln und Skelett —

und was wissenschaftlich hilft

DREAM AND DO IT · Coaching · Sitzen & Seitenschlafen
Nicholas Chilala — Training und Coaching



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

"SITZEN IST DAS NEUE RAUCHEN"

Der zugespitzte Satz stammt aus dem Umfeld des Mayo-Clinic-Forschers James Levine, der mit seinem Konzept NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) zeigte, wie viel Energie und gesundheitlicher Nutzen allein in alltäglicher Bewegung – Stehen, Gehen, Haltungswechsel – steckt. Wörtlich genommen ist der Vergleich übertrieben, doch die zugrunde liegende Forschung ist real: Eine große Metaanalyse von Biswas und Kollegen (2015, *Annals of Internal Medicine*) mit über 1 Million Teilnehmenden fand, dass langes tägliches Sitzen unabhängig von sportlicher Aktivität mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2, bestimmte Krebsarten und Gesamtmortalität verbunden ist.

Wichtige Einordnung liefert Ekelund und Kollegen (2016, *The Lancet*): Menschen, die täglich viel sitzen, aber zugleich ausreichend aktiv sind (rund 60–75 Minuten moderate Bewegung pro Tag), zeigen kein erhöhtes Mortalitätsrisiko mehr. Sitzen ist also kein unausweichliches Schicksal – es ist ein Risiko, das sich durch Bewegung an anderer Stelle gezielt abfedern lässt.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Biswas, A. et al. (2015). Sedentary time and its association with risk for disease incidence, mortality, and hospitalization in adults. *Annals of Internal Medicine*, 162(2), 123–132. ·

Ekelund, U. et al. (2016). Does physical activity attenuate associations between sitting time and mortality? *The Lancet*, 388(10051), 1302–1310.



GESUNDHEIT & BEWEGUNG

FOLGEN FÜR MUSKELN & SKELETT — UND WAS HILFT

Der tschechische Physiotherapeut Vladimir Janda beschrieb, wie dauerhaft einseitige Körperhaltung zu einem typischen Muster aus verkürzten und abgeschwächten Muskelgruppen führt — dem sogenannten oberen und unteren Cross-Syndrom. Beim Sitzen verkürzen sich Hüftbeuger und Brustmuskulatur, während die Gesäßmuskulatur ("Gluteal Amnesia") und die tiefe Nackenmuskulatur an Aktivierung verlieren. Ergebnis: ein nach vorn gezogenes Becken, ein runder oberer Rücken und ein vorgeschobener Kopf.

Auch die häufigste Schlafposition ist nicht folgenlos: Seitenschlaf (bei geschätzt 60–70 % der Erwachsenen die bevorzugte Position) kann bei falscher Kissenhöhe die Halswirbelsäule dauerhaft seitlich abknicken lassen und begünstigt durch das Körpergewicht auf der Schulter ein Einklemmen der Rotatorenmanschette (Impingement), wenn immer dieselbe Seite belastet wird.

Risiko	Gegenmaßnahme
Verkürzte Hüftbeuger, inaktive Glutes durch Sitzen	Alle 30–60 Min. aufstehen ("Bewegungs-Snacks"), Hüftbeuger-Dehnung, Glute Bridges
Rundrücken, vorgeschobener Kopf (oberes Cross-Syndrom)	Brustwirbelsäulen-Mobility, Türrahmen-Dehnung Brust, Face Pulls / Reverse Flys
Einseitige Schulterbelastung im Seitenschlaf	Seiten regelmäßig wechseln, Kissen zwischen die Knie für neutrale Hüfte
Kissenhöhe passt nicht zur Schulterbreite	Kissen so wählen, dass die Halswirbelsäule in gerader Verlängerung der Brustwirbelsäule bleibt

Praxistipp: Ein Timer für stündliches Aufstehen bewirkt oft mehr als ein einzelnes Mobility-Programm — Regelmäßigkeit schlägt Perfektion.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGE

Janda, V. (1987). Muscles and motor control in low back pain. In *Physical Therapy of the Low Back*. Churchill Livingstone. · Levine, J. A. (2004). Non-exercise activity thermogenesis (NEAT). *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 18(4), 679–702.